

山东大学齐鲁医院
检查报告单

姓名: 王文武 性别: 男 年龄: 57岁 病人来源: 住院
科室: F13C病区 住院号: 26000047 床号: 030 病人ID: 0013949696
诊断名称: 扁桃体恶性肿瘤 申请单号: 0051457876

检查所见:

右侧软腭-腭扁桃体软组织不规则增厚强化, 边界不清, 上下范围约5.5cm (SE567.IM15), T1WI呈等信号, FS T2WI呈稍高-高信号, 局部累及口底及咽后壁、右侧壁。扫及层面骨质信号未见明显异常。颈部见多发淋巴结显示, 较大者位于左颈部II区, 短径约1cm, 强化较均匀。

检查结论:

右侧软腭-腭扁桃体软组织增厚强化, 考虑肿瘤, 请结合临床及其他专科检查
颈部稍大淋巴结

报告医师: 蒋丰洋/潘迪

审核医师: 韩业明

检查日期: 2026-01-01 14:22:52

报告日期: 2026-01-02 08:15:58

本报告仅供临床医生参考

山东大学齐鲁医院
超声检查报告单

姓名: 王文武 性别: 男 年龄: 57岁 病人来源: 住院
科室: F13C病区 住院号: 26000047 床号: 030 病人ID: 0013949696
诊断名称: 扁桃体恶性肿瘤 申请单号: 0051457868

超声所见:

升主动脉 32.0mm (21.0~36.0mm) 左房前后径 36.0mm (24.0~40.0mm) 左室前后径 45.0mm (39.0~55.0mm)
室间隔 11.0mm (7.0~12.0mm) 左室后壁 9.0mm (6.0~11.0mm) 右室前后径 23.0mm (15.0~31.0mm)
右房长径 48.0mm (35.0~55.0mm) 右房横径 32.0mm (25.0~45.0mm) 主肺动脉 22.0mm (15.0~28.0mm)
EDV 87.0ml (46.0~128.0ml) ESV 31.0ml (16.0~56.0ml) LVEF(simpson) 0.64 (0.53~0.78)

一、各心腔和大血管超声扫查以及室壁运动分析:

心房正位, 心室右袢, 房、室及大血管连接关系正常; 房、室间隔未见明显回声中断; 左、右室壁动度正常; 各组瓣膜结构未见明显异常。

二、彩色和频谱多普勒:

- 收缩期左房内可见分布少量的二尖瓣反流束;
- 收缩期右房内可见分布局限的三尖瓣反流束, CW测最大反流压差约21mmHg, 估测肺动脉收缩压约26mmHg;
- 舒张期左室流出道可见分布较广泛的主动脉瓣反流束;
- 舒张期右室流出道可见分布少量的肺动脉瓣反流束;
- PW测二尖瓣前向血流频谱E峰<A峰。

超声提示:

主动脉瓣反流(轻-中度)
三尖瓣反流(轻度)
左室充盈异常

记录人员: 刘晓琳

诊断医师: 刘晓琳

检查日期: 2026-01-02 10:23:28

报告日期: 2026-01-02 10:23:28

本报告仅供临床医生参考

山东大学齐鲁医院
超声检查报告单

姓名：王文武 性别：男 年龄：57岁 病人来源：住院
科室：F13C病区 住院号：26000047 床号：030 病人ID：0013949696
诊断名称：扁桃体恶性肿瘤 申请单号：0051457860

超声所见：

颈部扫查：

甲状腺右侧叶厚约1.7cm，左侧叶厚约1.6cm，峡部厚约0.3cm，内回声均匀。

腺体内探及多个囊实性结节，边界尚清，形态尚规则，大者位于左侧叶上极，大小约0.6*0.4cm。

双侧颈部相应区域未见异常肿大淋巴结。

超声提示：

甲状腺多发结节（TI-RADS分类：2类）

记录人员：于仁旭

诊断医师：于仁旭

检查日期：2026-01-01 15:30:06

报告日期：2026-01-01 15:30:06

本报告仅供临床医生参考